

Protocolo de rehabilitación posoperatoria musculoesquelética

Protocolo | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Alinear rehabilitación con procedimiento quirúrgico, restricciones y evolución de tejidos.

2. Alcance y condiciones de uso

Utilizar únicamente para la intervención realmente ofertada, con recursos y competencia comprobados. Requiere valoración, consentimiento específico cuando procede, manual de equipos y registro clínico autenticado.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Fisioterapeuta responsable	Valorar, individualizar, informar, vigilar y registrar.
Ejecutor según proceso	Aplicar la técnica o tarea para la que tiene competencia.
Verificador o titular	Comprobar recursos, evidencias y acciones de mejora.

4. Recursos y preparación

Reporte y restricciones disponibles, área y ayudas de carga, plan de fase individual y comunicación con equipo tratante.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Verificar nombre completo e identificación, motivo, objetivo y evolución desde la última a

Verificar nombre completo e identificación, motivo, objetivo y evolución desde la última atención. Revisar el plan y consentimiento; explicar el contacto, equipo y posibilidad de detener, antes de preparar la técnica.

2. Valorar y documentar: Tipo y fecha de cirugía, reporte disponible, restricciones del ciruj

Valorar y documentar: Tipo y fecha de cirugía, reporte disponible, restricciones del cirujano, herida, dolor, edema y signos de infección o trombosis. Registrar lo encontrado y la decisión de continuar, modificar, aplazar o remitir. No copiar una lista como si hubiera sido evaluada.

3. Preparar el ambiente, privacidad, ayudas y dispositivos que la intervención requiere; insp

Preparar el ambiente, privacidad, ayudas y dispositivos que la intervención requiere; inspeccionar integridad, limpieza y funcionamiento. Confirmar disponibilidad de recursos para detener y responder ante complicación.

4. Aplicar con este criterio específico: Definir fase de rehabilitación por información clíni

Aplicar con este criterio específico: Definir fase de rehabilitación por información clínica, sin calendario universal. Registrar límites de carga y movimiento, ayudas, ejercicio y criterios de avance. La programación, medidas o dosis deben poder reconstruirse desde la historia de la sesión.

5. Vigilar y utilizar los siguientes criterios de interrupción: Fiebre, drenaje, dolor o edem

Vigilar y utilizar los siguientes criterios de interrupción: Fiebre, drenaje, dolor o edema inusual, disnea o sospecha de trombosis requieren valoración médica o urgencias; no tratar con masaje una trombosis sospechada. Primero controlar el riesgo y atender a la persona; después documentar y analizar el evento.

6. Cerrar y reevaluar con estas actividades: Coordinar dudas con equipo tratante, reevaluar f

Cerrar y reevaluar con estas actividades: Coordinar dudas con equipo tratante, reevaluar función y adherencia, documentar cambios de fase y continuar autocuidado. Registrar conducta y autoría, acordar fecha o condición de seguimiento y comprobar comprensión de las recomendaciones.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Antes de cada sesión: elegibilidad, consentimiento, recursos y cambios clínicos.

Durante: vigilancia proporcional a la técnica; nunca usar un consentimiento como sustituto de contraindicación.

Después: respuesta, piel cuando procede, educación, limpieza, registro y seguimiento.

Indicador local: sesiones con parámetros y respuesta trazables / sesiones revisadas x 100.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.5 y 11.3.1.22-26: información documentada, prácticas seguras, recursos y formación. Limitar técnicas al portafolio y verificar condiciones reales.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Paciente e identificación	
Fecha hora sesión	
Objetivo y diagnóstico fisioterapéutico	
Tamizaje y precauciones	
Consentimiento y autenticación	
Técnica región posición	
Equipo código y parámetros reales	
Vigilancia y respuesta	
Educación alarmas y conducta	
Autor y autenticación	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Ejercicio profesional

Ley 528 de 1999, artículos 1-3 y 27, principios, competencias y consentimiento previo. El contenido exige evaluación integral y fundamento científico; no garantiza resultados ni amplía competencias por tener un formato.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66199>

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576